

INFORME DE CONSULTA — TRASTORNOS COGNITIVOS

Caso de prueba con datos ficticios, generado para testeo del sistema NeuroInsight (Anexo C)

Sexo: Varón

Edad: 79 años

Anamnesis

Paciente remitido por su médico de atención primaria por un cuadro de deterioro cognitivo de instauración insidiosa y curso progresivo, de aproximadamente tres años de evolución. Según refiere la familia, presenta olvidos frecuentes de conversaciones recientes y citas, repite preguntas ya respondidas, y en los últimos meses ha requerido ayuda para la gestión de la medicación y de las finanzas domésticas, tareas que hasta entonces realizaba con autonomía; se objetiva además desorientación ocasional en entornos poco familiares. No refiere alteraciones motoras ni sensitivas asociadas. En la valoración neuropsicológica realizada en consulta, el MMSE fue de 16/30, con errores destacados en memoria diferida, orientación temporal y praxis constructiva, hallazgos compatibles con una afectación cognitiva de grado moderado.

Exploración complementaria

Se completó el estudio con punción lumbar para determinación de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo. La tau total fue de 620 pg/mL. La beta-amiloide 42 fue de 380 pg/mL. Ambos valores son compatibles con un perfil bioquímico patológico; dado que la punción lumbar ya aportó un perfil concluyente, no se consideró necesario completar el estudio con biomarcadores en plasma. El estudio genético solicitado confirmó la presencia del alelo APOE $\epsilon 4$ en heterocigosis (genotipo $\epsilon 3/\epsilon 4$). La resonancia magnética craneal mostró atrofia hipocampal bilateral de grado moderado-severo, de predominio en regiones mediales temporales. El volumen hipocampal estimado fue de 2650 mm³, sin otros hallazgos relevantes asociados.

Juicio clínico

A la vista del conjunto de hallazgos clínicos, neuropsicológicos, bioquímicos y de neuroimagen, la impresión diagnóstica es de enfermedad de Alzheimer en fase de demencia leve-moderada.

Documento ficticio generado exclusivamente con fines de verificación técnica del pipeline de extracción y predicción de NeuroInsight. No corresponde a ningún paciente real.